# 9.7 La drépanocytose

## A. Généralités

La **drépanocytose** est une **maladie génétique qui modifie l'hémoglobine.**

Elle affecte indifféremment les deux sexes et se rencontre plus spécifiquement dans les populations d'Afrique centrale d'Inde, d'Amérique du sud (Brésil), du pourtour du bassin méditerranéen, des Antilles et chez les Afro-Américains. Les flux migratoires expliquent sa fréquence en métropole : c'est la maladie génétique la plus fréquente en Île-de-France. Pour que la maladie existe, il faut que chaque parent ait transmis un gène défectueux.

**Les conséquences de la drépanocytose**

Les globules rouges, qui ont normalement la forme d'un disque aplati sur ses deux faces, sont déformés lorsqu'ils contiennent l'hémoglobine anormale. Ils ont la forme d'une faucille, en particulier lorsqu'ils sont pauvres en $O_2$.

Les conséquences de cette déformation sont :

- **l'occlusion** des capillaires, puisque les globules trop gros ne peuvent plus passer ; ceci entraîne une anoxie et éventuellement une nécrose dans différents organes : rate, os, muscles, cerveau, tube digestif, reins, poumons ;
- **l'anémie** car les globules rouges coincés dans la rate sont détruits, ce qui se traduit par un ictère suite à la libération d'un pigment contenu dans ces globules.

Les crises sont déclenchées par ce qui :

- facilite le blocage des globules rouges dans les capillaires :
  - déshydratation (pouvant être favorisée par la fièvre, la prise d'alcool) ;
  - gêne de la circulation sanguine (effet garrot d'un vêtement, mauvaise position d'un membre ;
  - vasoconstriction due au froid) ;
- augmente l'hypoxie : effort musculaire qui consomme de l'$O_2$, altitude (même en avion pressurisé), tabac…

Par ailleurs, ces patients tolèrent mal les efforts à cause de l'anémie et sont sujets aux infections car la rate ne joue plus son rôle protecteur.

## B. Signes spécifiques

**Rechercher par l'interrogatoire de la victime ou de l'entourage :**

- les **antécédents** : familiaux…
- le(s) **facteur(s) déclenchant(s)** : efforts, voyage en avion, froid…

**Rechercher ou apprécier :**

- des **douleurs musculaires**, thoraciques, **abdominales ou osseuses**, parfois intolérables ;
- les **signes d'un AVC ;**
- de **la fièvre ;**
- **une pâleur ou un ictère ;**
- une **tachycardie ;**
- un **essoufflement ;**
- **un priapisme (érection prolongée et douloureuse).**

## C. Conduite à tenir spécifique

**En parallèle de la réalisation d'un bilan complet et des gestes de secours adaptés, la conduite à tenir impose de :**

1. **Administrer de l'oxygène**, par inhalation, **si la $SpO^2$ est < 95%** (cf. fiche technique 20.1).
2. **Déshabiller** la victime, en présence de fièvre.
3. **Réchauffer** la victime, si elle a froid.
4. **Aider à la prise de médicaments** contre la fièvre, après contact avec la coordination médicale.

En cas de douleurs intenses, la médicalisation peut être justifiée.